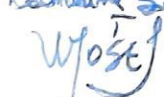
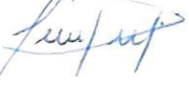


	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 1 de 21

Protocolo de Curaciones Complejas

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr. Orlando

Leyton A. Peralillo

Elaborado por: Joselyn Castro Cornejo Sandy Guajardo Padilla María José Solís L. Catherine Soto Farías.	Revisado por: María Carolina Cornejo Z.	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E
Cargo: Enfermeras CESFAM Peralillo.	Cargo: Enfermera supervisora de curaciones	Cargo: Director CESFAM Peralillo.
Fecha: 22 de Febrero 2024	Fecha: 27 de Febrero 2024	Fecha: 12 de Marzo de 2024
Firma:  Catherine Soto.  W José 	Firma: 	Firma: 

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 2 de 21

I. INTRODUCCIÓN

Las heridas constituyen un problema de salud que afecta tanto al usuario como a su entorno, produce altos costos hospitalarios y aumenta los días de hospitalización. Estos procesos de recuperación de la piel pueden ocurrir de manera tórpida y dolorosa aumentando la incomodidad y estrés en el usuario. Desde los últimos 50 años han ocurrido múltiples cambios en las técnicas curativas, los avances tecnológicos han permitido el estudio de nuevos apósitos que permiten favorecer el proceso de cicatrización así como también disminuir las infecciones y complicaciones. Ante esto, dentro del manejo de distintos tipos de lesiones, se contemplan en especial el de úlcera por presión, que se puede evidenciar con mayor frecuencia en los usuarios con cierto grado de dependencia o con comorbilidad clínica, siendo estos mayormente manejados en atención primaria, generando repercusiones económicas a la familia y a nuestro sistema de salud.

El propósito del presente protocolo recae en optimizar la intervención del equipo disciplinario en función de un mejor abordaje del manejo clínico de heridas complejas con el fin de entregar continuidad en la atención y ser una herramienta de apoyo para el personal de salud.

II. OBJETIVOS

a. Objetivo General

Estandarizar el Procedimiento de Curaciones Complejas, para la pronta recuperación del usuario, disminuyendo factores de riesgo que retrasen el proceso de cicatrización.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 3 de 21

b. Objetivos específicos.

- Identificar características de los diferentes tipos de heridas y úlceras.
- Establecer criterios de técnica aséptica en el manejo de heridas complejas.
- Establecer patrones de conducta de acuerdo a la valoración de la herida y úlceras.
- Identificar y aplicar el apósito correcto para los diferentes tipos de heridas y úlceras.

III. ALCANCE

a.- Ámbito de la aplicación: Dirigido a profesionales de enfermería que realizan curaciones avanzadas en el CESFAM Dr. Orlando Leyton Astorga Peralillo.

b.- Población de la aplicación: A todo usuario que requiera algún tipo de curación compleja en el CESFAM Dr. Orlando Leyton Astorga Peralillo.

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- **De la indicación:** Médicos y enfermeras del establecimiento.
- **De la ejecución:** Enfermeras y TENS en función delegada con aprobación de curso de manejo avanzado de heridas.
- **De la supervisión:** Procedimientos de enfermería: Enfermera de cabecera sector urbano, Urgencia: Enfermera referente administrativa SUR, Postas de Salud Rurales: Enfermeras de Postas de Salud Rurales.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 4 de 21

V. DEFINICIONES

- **Úlcera:** Lesión espontánea o accidental, cuya etiología puede referirse a un proceso patológico sistémico que no cicatriza en el intervalo temporal esperado.
- **Úlcera Pie Diabético:** Ulceración, infección y/o gangrena del pie, asociados a neuropatía diabética y diferentes grados de enfermedad arterial periférica. Es la consecuencia de una descompensación sostenida de los valores de glicemia, que desencadenan alteraciones neuropatías (70% de las úlceras diabéticas), isquemia (15% de los casos), neuroisquémicas (15% de los casos) y propensión especial a sufrir infecciones, y alteraciones que las llevan a presentar riesgo de lesiones y amputaciones.
- **Quemaduras:** lesiones producidas en los tejidos vivos debido a la acción de diversos agentes físicos, químicos o eventualmente biológicos que provocan alteraciones que varían desde un simple enrojecimiento hasta la destrucción total de las estructuras afectadas. En algunos casos puede provocar alteraciones sistémicas. Se utilizará clasificación según Benaim.
- **Ambiente fisiológico:** Condiciones que permiten mantener un ambiente húmedo que impide la desecación y la maceración favoreciendo la cicatrización.
- **Curación Avanzada:** Corresponde a la curación No Tradicional que se efectúa limpiando la herida o úlcera con solución fisiológica, dejando como cobertura un apósito interactivo, bioactivo o mixto. La frecuencia de la curación depende de las condiciones de la lesión y el apósito elegido.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 5 de 21

- **Valoración de la úlcera venosa:** se refiere a la identificación y descripción de parámetros establecidos que permiten la clasificación según diferentes variables.

- **Valoración de úlcera de pie diabético:** Valoración integral que se realiza al usuario diabético con presencia de ulceración con el fin de describir e identificar las características de la lesión, permitiendo tipificarla y llevar un buen control de su evolución.

- **Aspecto:** Evalúa el color que predomina en la lesión. Este puede ser:

- Eritematoso o epitelial: Aspecto rosado pálido, frágil, sin pérdida de la integridad cutánea.

- Enrojecido: Tejido de color rojo brillante con pérdida de la epidermis.

- Amarillo pálido /esfacelado: color blanco o amarillo pálido, húmedo.

- Necrótico: tejido muerto, seco, duro y de color negro.

- **Extensión:** Diámetro de borde a borde de la lesión. Si existen dos lesiones separadas por más de 3 cm se miden independientemente, si están separadas por menos de 3 cm. se miden como una sola.

- **Profundidad:** Si la úlcera tiene tejido esfacelado o necrótico, se debe desbridar previamente. Si esto no es posible, se asigna máximo puntaje. Si hay compromiso de hueso, igualmente se asigna máximo puntaje.

- **Exudado:** Se forma en la superficie como resultado de la pérdida de líquido de los vasos sanguíneos pequeños, disminuye con la cicatrización y desaparece con la epitelización. Según la cantidad, se clasifica en:

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 6 de 21

- Escaso: apósito primario seco al retirarlo.
- Moderado: apósito primario hasta 50% humedecido.
- Abundante: apósito primario totalmente humedecido, traspasando el exudado al apósito secundario en 50-75%.
- Muy abundante: apósito primario y secundario totalmente empapados, llegando a la maceración de la piel.

Según la calidad, se clasifica en:

- Seroso: Líquido claro, transparente, o de color amarillo claro.
- Turbio o hemático: Líquido más espeso formado por la mezcla del exudado del proceso de cicatrización de la herida y detritus producto del desbridamiento. Puede ser de color blanco o rojo.
- Purulento: Líquido espeso cremoso, formado por una mezcla de bacterias y de macrófagos muertos o desvitalizados. Puede ser de color amarillo-verdoso.
- Purulento gangrenoso: líquido espeso, cremoso, de color verde o café, con trozos de tejido necrótico (valoración ulcera pie diabético).
- **Tejido granulatorio:** Tejido conectivo rojizo, húmedo y frágil que llena la herida durante la fase proliferativa de la curación. Se mide en porcentaje.

• **Edema:** Es el exceso de líquido en los tejidos subyacentes a la herida y se mide a través de la presión dactilar.

Edema + = Alrededor de la úlcera.

Edema ++ = El 50% de la extremidad inferior está edematosa.

Edema +++ = el 100% del pie está edematoso.

Edema ++++ = el pie está totalmente edematoso afectando también la extremidad inferior.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 7 de 21

- **Dolor:** La medición del dolor se puede realizar en distintas escalas como por ejemplo de uno a diez (ENA) o utilizando la Escala Visual Análoga (EVA).

Piel circundante: La piel cercana a la herida puede sufrir alteraciones de la integridad cutánea por efectos mecánicos o relacionados con el proceso inflamatorio, los que pueden extender la lesión o dejar secuelas. Esta se clasifica en:

- Piel sana: Piel indemne.
- Descamación: Exfoliación de células queratinizadas de tamaño variable, color plateado, blanco o tostado que indica sequedad de la piel y propensión a grietas y fisuras.
- Piel eritematosa: Enrojecida, irritada. Si se acompaña de calor local puede ser signo de infección.
- Piel macerada: La piel se observa blanca, húmeda, frágil, con epidermis que se elimina espontáneamente. Se produce al estar en contacto con un medio húmedo.
- Piel gangrenada: Piel inflamada. Con calor local, enrojecida, y a veces de color oscuro (morada o café) frágil y dolorosa que puede presentar crépitos a la palpación.

- **Arrastre Mecánico:** Lavado o irrigación de la herida o úlcera para eliminar los agentes contaminantes que pueden actuar como fuentes de infección. Este procedimiento es ideal para heridas infectadas o zonas de difícil acceso. Se recomienda: Solución Ringer Lactato, Solución NaCl 0,9% (suero fisiológico) y Agua bidestilada. Se realizará con duchoterapia a través de un matraz de solución fisiológica al que se le realizarán 20 a 30 orificios con aguja N° 19 o 21, esta técnica es ideal para úlceras grado III, IV y V. También se puede realizar con jeringa de 20

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 8 de 21

o 35 cc con aguja N° 19, siendo ideal para úlceras grado I y II. Estas dos técnicas generan presiones entre $1-4\text{kg/cm}^2$, las cuales son efectivas y seguras para no destruir tejido granulatorio.

- **Desbridamiento:** El Desbridamiento médico-autolítico, consiste en colocar un apósito bioactivo (hidrogel) sobre la úlcera, previo lavado por arrastre mecánico con suero fisiológico. El desbridamiento quirúrgico consiste en retirar el tejido desvitalizado con uso de bisturí.

- **Coberturas y Apósitos:** Es un material de curación que se aplica directamente sobre la herida o úlcera. La herida puede ser cubierta con uno o más apósitos, ya sean del mismo o de distintos tipos. El apósito que va en contacto con la herida será considerado un apósito primario. Si se deja otro apósito sobre éste, será considerado apósito secundario.

- **Disminución carga bacteriana:** aplicación de productos sobre la herida o úlcera que permiten disminuir el número de bacterias, esto se puede realizar con clorhexidina jabonosa 2% o con polihexanida con betaína (Prontosan).

VI. DESARROLLO

a.- CONCEPTOS

El concepto de herida hace referencia a la presencia de disrupción de la anatomía de la piel, que evoluciona en lesiones abiertas donde se pierde la continuidad del tejido, desencadenando un proceso fisiológico de reparación. Se puede diferenciar entre herida aguda y crónica.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 9 de 21

- **Herida Aguda:** Herida de corta duración y de rápida transformación, que fluctúa entre 3 y 6 semanas dependiendo de las condiciones en las que esta se encuentre.

- **Herida crónica:** es aquella disrupción que no se cura en un conjunto ordenado de etapas y en tiempo predecible, aquellas donde su proceso curativo asciende de los 3 meses y más.

Es importante considerar el tiempo de evolución desde la aparición de la herida para comprender el grado de contaminación, que se diferencia en:

- **Limpias:** Menos de 6 horas de evolución, con mínimo daño tisular y no penetrante.
- **Sucias:** Más de 6 horas de evolución, penetrantes o con mayor daño tisular.

b.- VALORACIÓN DE LAS HERIDAS.

La valoración es considerada como la etapa de preparación, donde ocurre la recolección de información mediante la visualización de las características clínicas presentes en el usuario, en este caso son los signos y síntomas que puedan estar asociados a la presencia de una herida. De esta forma se identifican las necesidades de cada usuario para la elección adecuada de insumos a utilizar. Esta fase entregará las directrices para una atención individualizada, atingente y sólida que permitirá la planificación de los cuidados.

Parte de la valoración del usuario considera la presencia de patologías crónicas, que pueden ser las desencadenantes de este problema, es fundamental la compensación de estas patologías para lograr los mejores resultados en los procesos curativos.

Durante este proceso de valoración es posible identificar el estadio de la herida

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 10 de 21

de los cuales se pueden clasificar según las características que presente.

Valorar e identificar el estadio de la herida inicialmente es fundamental para iniciar un plan de cuidados, sin embargo la valoración constante permitirá evaluar la evolución de ésta para ir adaptando los cuidados a las nuevas necesidades del usuario.

ÚLCERAS

El manejo de las úlceras se realiza de igual manera que el manejo de las heridas, utilizando la misma técnica de curación avanzada y eligiendo los insumos a utilizar según las necesidades del usuario. Existen también diferentes tipos de úlceras asociadas a la disminución del riego sanguíneo, tanto arterial como venoso, o de insuficiencia mixta.

- **Úlceras arteriales:** Poseen características específicas tales como:
 - Bordes definidos
 - Tamaño pequeño y de aspecto redondeado
 - Piel circundante pálida, fría al tacto, sin presencia de vello y delgada
 - Dolor intenso, profundo hasta invalidante
 - Alteración de pulsos según nivel de obstrucción (afecta pulso pedio, tibial posterior, poplíteo y femoral).
- **Úlceras venosas:** Poseen características específicas tales como:
 - Pulsos presentes
 - Tamaños variables y de bordes indefinidos
 - Únicas o múltiples

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 11 de 21

- Bordes de coloración roja, con la cronicidad pasa a ser pálido y oscuro.
- Pueden ser moderadamente dolorosas o incluso indoloras.

- **Úlceras de pie diabético:** Para clasificar este tipo de úlceras se ocupa el diagrama de Meggit – Wagner y san Elian.

c.- CURACIÓN

Objetivos del proceso de curación:

- Remover tejido necrótico y cuerpos extraños.
- Identificar y eliminar la infección.
- Absorber exceso de exudado.
- Mantener ambiente húmedo en las heridas.
- Mantener un ambiente térmico.
- Proteger el tejido de regeneración, del trauma y la invasión bacteriana.

CLASIFICACIÓN DE LAS CURACIONES:

- **Curación simple o tradicional:** Curación en ambiente seco, se utilizan apósitos pasivos tipo gasa, se realiza la limpieza de la zona y se cubre con apósito tradicional.

- **Curación avanzada:** Aquella donde se mantiene el ambiente húmedo fisiológico, se utilizan apósitos activos y la frecuencia de curaciones según evolución.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 12 de 21

d. TÉCNICA DE LA CURACIÓN COMPLEJA.

- **Limpieza e irrigación.**

El aseo de heridas es fundamental para el proceso de recuperación, permite eliminar los residuos y materia inorgánica presentes en la herida que entorpecen la cicatrización correcta, así como también permite mantener un ambiente ideal para favorecer la granulación y disminuye la carga bacteriana.

El arrastre mecánico: es la técnica que permite limpiar la herida, con pinza y tórula estéril empapada en solución salina, con esto es posible disminuir y eliminar agentes contaminantes.

Dentro de otros tipos de arrastre mecánico se encuentra: Duchoterapia, la limpieza con matraz de suero directo y el lavado con jeringa.

- **Soluciones utilizadas para aseo de heridas**

- Suero Fisiológico: Solución de elección y de bajo costo, mantiene el ambiente fisiológico sin aportar oligoelementos o nutrientes.
- Suero Ringer lactato: Esta solución aporta oligoelementos que favorecen la granulación, es la solución ideal a utilizar pero de mayor costo monetario.
- Agua bidestilada: Se utiliza a falta de las soluciones anteriores

Es importante tener en consideración la temperatura de las soluciones, de preferencia usar soluciones tibias. La solución fría produce vasoconstricción disminuyendo la llegada de nutrientes a la zona y la solución a alta temperatura produce vasodilatación favoreciendo la hemorragia y retardando la cicatrización.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 13 de 21

- **Desbridamiento**

Es una técnica que permite eliminar el tejido desvitalizado o necrótico, con la finalidad de exponer el tejido vivo en recuperación. Puede realizarse bajo técnica quirúrgica o con apósitos interactivos. El tejido desvitalizado actúa como barrera mecánica retardando la granulación, impide la aproximación de los bordes y se considera un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos favoreciendo la sobre infección de las heridas. Se debe desbridar cuando existe abundante cantidad de tejido esfacelado o necrótico.

- **Protección de heridas**

El mecanismo de acción consiste en formar una barrera protectora sobre la piel, que la protege de la humedad de los fluidos corporales. Esto evita las lesiones perilesionales de las heridas muy exudativas, en sitios de inserción de drenajes u ostomías. Se pueden encontrar comúnmente como crema o aerosol. Se recomienda la utilización de ácidos grasos hiperoxigenados como cavilón o linovera.

- **Aplicación de Apósitos**

Los apósitos o coberturas permiten aislar, proteger y optimizar el proceso de cicatrización.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 14 de 21

TIPOS DE APÓSITOS

- **Apósitos Pasivos:** Son apósitos simples y de bajo costo, que sirven principalmente para proteger, aislar, taponar y absorber (gasas, apósito tradicional y espumas).
- **Apósitos Interactivos:** Son más complejos que los apósitos pasivos, presentan excelentes resultados en el manejo de las heridas, son de más alto costo que los anteriores, sirven para mantener un ambiente fisiológico húmedo en la herida o úlcera. (tull, espumas hidrofílicas, apósitos transparentes adhesivos y no adhesivos).
- **Apósitos Bioactivos:** Utilizan una tecnología más elaborada que los anteriores, están diseñados para mantener una humedad fisiológica en la herida o úlcera y permitir la oxigenación (hidrocoloides, hidrogel y alginatos).
- **Apósitos Mixtos:** Son apósitos con diferentes niveles de permeabilidad que combinan las características de distintos tipos de apósitos: pasivos, interactivos, bioactivos y otros componentes. De acuerdo a su función o característica principal estos apósitos se clasifican en: Antimicrobianos, Hiperosmóticos y Regeneradores.

e.- PROCEDIMIENTOS

MATERIALES

- Carro de curación o mesa mayo.
- Equipo de curación estéril (bandeja, pinzas, tijeras)
- Guantes de procedimientos.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 15 de 21

- Suero fisiológico o Ringer Lactato.
- Jeringa según necesidad.
- Agujas optativo para irrigación.
- Tela adhesiva.
- Gasas.
- Apósitos.
- Bolsa de desechos o basurero (residuos doméstico o residuos especiales según normativa REAS)

f.- DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

1. Lavado de manos clínico.
2. Reunir material y llevarlo a la sala de curaciones o lugar donde se realizará esta.
3. Informarle el procedimiento al usuario.
4. Colocarse guantes de procedimiento.
5. Retirar cuidadosamente la cinta quirúrgica siguiendo la dirección del vello. Mientras más lento es la remoción de la cinta, menos es el daño y la incomodidad del paciente.
6. Retirar el apósito y eliminarlo en basurero de residuos especiales, observando contenido (color, olor, cantidad).
7. Retirarse los guantes de procedimiento.
8. Lavado de manos clínico.
9. Colocarse guantes de procedimiento.
10. Ordenar material preservando su esterilidad.
11. Delimitar áreas (limpia y sucia), tanto en la herida, como en equipo de curación.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 16 de 21

12. Observar características de la herida, valorar signos de infección o zonas induradas, presionar si es necesario y cuidando de mantener la esterilidad.

13. Realizar arrastre mecánico, con gasas o irrigando con suero, ya sea a través de jeringa o matraz. El arrastre siempre debe ser de la zona más limpia hasta la más sucia de la herida y utilizando una gasa por vez.

14. Eliminar gasas utilizadas.

15. Desbridar el tejido susceptible de ser retirado y de acuerdo al grado de adherencia que esté presente.

16. Colocar apósitos según características de la herida y disponibilidad del servicio. Cubrir con apósito secundario en caso necesario.

17. Colocar cinta quirúrgica sobre la piel limpia y seca.

18. Dejar cómodo al paciente.

19. Retirar material, eliminar residuos domiciliarios u orgánicos y depositar la caja de curación en agua con detergente enzimático.

20. Sacar y eliminar guantes de procedimiento.

21. Lavado de manos clínico.

20. Registrar el procedimiento: Las curaciones complejas serán registradas en ficha clínica.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 17 de 21

VII. INDICADOR.

El procedimiento especificado será evaluado en los puntos de verificación: Procedimientos de enfermería, Urgencia, Postas de Salud Rurales (Se exceptúa Calleuque ya que en esta posta no se realizan procedimientos de enfermería de ningún tipo).

Título	Porcentaje de cumplimiento procedimiento de curación herida compleja según protocolo vigente en las Unidades de: Procedimientos de enfermería, Urgencia, Postas de Salud Rurales en el semestre. (Anexo 1)
Propósito	Evaluar la correcta ejecución de curaciones de heridas complejas según protocolo para prevenir eventos adversos asociados.
Tipo	Proceso.
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de características aprobadas según pauta de cotejo en curación de heridas complejas unidades: Procedimientos de enfermería, Urgencia, Postas de Salud Rurales en el semestre}}{\text{N}^\circ \text{ de características evaluadas según pauta de cotejo en curación de heridas complejas unidades: Procedimientos de enfermería, Urgencia, Postas de Salud Rurales en el semestre}} \right) \times 100.$
Fuente de datos	Primaria: Pauta de cotejo. Secundaria: Registro ficha clínica.
Umbral	Mayor igual a 88%.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 18 de 21

Periodicidad de evaluación	Semestral
Metodología de selección de casos.	Población: Corresponde a una muestra por conveniencia según como se indica: -Puntos de verificación procedimientos de enfermería y urgencia: 15 por semestre en cada punto. Punto de verificación Postas de Salud Rurales: 5 por semestre en cada Posta. La supervisión se hará según pauta directa por oportunidad hasta cumplir con la muestra requerida.
Responsables	Procedimientos de enfermería, Urgencia y Postas de Salud Rurales: Enfermeras CESFAM y Postas.
Observaciones	

VIII. DISTRIBUCIÓN

- Servicio de Urgencia Rural CESFAM Peralillo
- Postas de salud rurales.
- Enfermeras Sector Urbano y Rural.
- TENS curaciones Sector Urbano, SUR y TENS de Postas.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Salud (2005) Curación avanzada de las úlceras de pie diabético. Chile.

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 19 de 21

Hospital Clínico San Francisco-Pucón (2021), protocolo manejo de curaciones en heridas y úlceras, Chile.

X. AUTORES

Joselyn Castro Cornejo, Enfermera CESFAM Peralillo

María Carolina Cornejo Z, Enfermera CESFAM Peralillo

Sandy Guajardo Padilla, Enfermera CESFAM Peralillo

María José Solís L., Enfermera CESFAM Peralillo

Catherine Soto Farías, Enfermera CESFAM Peralillo.

XI. CONTROL DE CAMBIOS

Cambio	Fecha de cambio	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 20 de 21

XII. ANEXOS

ANEXO 1: Pauta de cotejo Procedimiento de curación avanzada de heridas
Unidades: Procedimientos enfermería, urgencia, Postas de salud rurales
CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

Características a evaluar.	SI	NO	N/A
Se realiza lavado de manos clínico.			
Se informa sobre el procedimiento al usuario/a.			
Se colocarse guantes de procedimiento.			
Retira cuidadosamente la cinta quirúrgica siguiendo la dirección del vello.			
Retira el apósito y elimina en basurero de residuos especiales, observando contenido (color, olor, cantidad).			
Se retira los guantes de procedimiento.			
Se realiza lavado de manos clínico.			
Se coloca guantes de procedimiento.			
Ordena el material preservando su esterilidad.			
Delimitar áreas (limpia y sucia), tanto en la herida, como en equipo de curación.			
Realiza arrastre mecánico, con gasas o irrigando con suero, ya sea a través de jeringa o matraz desde la zona más limpia hasta la más sucia de la herida y utilizando una gasa por vez.			
Elimina las gasas utilizadas.			

	PROTOCOLO CURACIONES COMPLEJAS	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 21 de 21

Desbrida el tejido susceptible de ser retirado y de acuerdo al grado de adherencia que esté presente.			
Coloca apósitos según características de la herida y disponibilidad del servicio.			
Coloca cinta quirúrgica sobre la piel limpia y seca.			
Retira material, elimina residuos domiciliarios u orgánicos. Deposita la caja de curación en agua con detergente enzimático.			
Se retira y elimina guantes de procedimiento.			
Realiza lavado de manos clínico.			
Registra el procedimiento en ficha clínica.			
Porcentaje de cumplimiento de la pauta (Sobre 85% se considera aprobada)			
Observaciones finales:			

UNIDAD EVALUADA:	
FECHA:	
PERSONA QUE EVALÚA:	
FIRMA:	